

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

त्रयो रोगमार्ग

त्रयो रोगमार्गा इति शाखा, मर्मास्थिसंधयः कोष्ठश्च ॥ (च.सू. ११/४८)

१. बाह्य रोगमार्ग :-

तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक् च, स बाह्यो रोगमार्गः ॥ (च.सू. ११/४८)

बाह्यमार्गज व्याधी :-

तत्र गण्डपिडकालज्यपचीचर्मकीलाधिमांसमषककुष्ठण्डगादयो विकारा
बहिर्मार्गजाश्च विसर्पश्चयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥
(च.सू. ११/४९)

२. मध्यम रोगमार्ग :-

मर्माणि पुनर्बस्तिहृदयमूर्धादिनि, अस्थिसन्धयोऽस्थिसंयोगास्तत्रोपनिबध्दाश्च
स्नायुकण्डराः स मध्यमो रोगमार्गः । (च.सू. ११/४८)

मध्यमरोगमार्गज व्याधी :-

पक्षवधग्रहापतानकार्दितशोषराजयक्ष्मास्थिसन्धिशूल गुदभ्रंशादयः शिरोहृद्बस्तिरोगादयश्च
मध्यममार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ (च.सू. ११/४९)

३. आभ्यन्तर रोगमार्ग :-

कोष्ठ पुनरुच्यते महारत्रोतः शरीरमध्यं महानिम्ननामपक्वाशयश्चेति
पर्यायशब्दैस्तन्त्रे स रोगमार्ग आभ्यन्तरः ॥ (च.सू. ११/४८)

आभ्यन्तर रोगमार्गज व्याधी :-

ज्वरातीसारच्छर्दलसकविसूचिकासश्वासहिक्कानाहोदर प्लीहादयोऽन्तर्मार्गजाश्च
विसर्पश्चयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः कोष्ठानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ (च.सू. ११/४९)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

मुत्रवह स्त्रोतस

- **मूलस्थान :**

मूत्रवहानां स्त्रोतसां बस्तिर्मूलं वङ्क्षणौ च। (च.वि.५/५)

मूत्रवहे द्वे, तयोर्मूलं बस्तिर्मेढ्र च। (सु.शा.९/१२)

- **दुष्टीहेतु :**

मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात्।

मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च॥ (च.वि. ५/१९)

- **दुष्टीलक्षणे :**

अतिसृष्टमतिबद्धं प्रकुपितमल्पाल्पमभीक्षणं वा बहलं सशूलं

मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्त्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। (च.वि.५/५)

- **विद्धलक्षणे :**

तत्र विद्धस्यानद्धबस्तिता मूत्रनिरोधः स्तब्धमेढ्रता च। (सु.शा. ९/१२)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

पुरीषवह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

पुरीषवहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदं च। (च.वि. ५/७)
पुरीषवहे द्वे, तयोर्मूलं पक्काशयो गुदं च। (सु.शा ९/१२)

- **दृष्टिहेतु :**

सन्धारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात् तथा।

वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च॥ (च.वि. ५/२१)

- **दृष्टिलक्षणे :**

कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशब्दशूलमतिद्रवमतिग्रथितमतिबहु चोपविशन्तं दृष्ट्वा
पुरीषवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्॥ (च.वि. ५/७)

- **विद्धलक्षणे :**

तत्र विद्धस्यानाहो दुर्गन्धता ग्रथितान्त्रता च॥ (सु.शा ९/१२)

वानाडोंगरी हिंगणा रोड नागपूर.

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

शुक्रवह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च। (च.वि ५/४)

शुक्रवहे द्वे, तयोर्मूलं स्तनौ वृषणौ च। (सु.शा ९/१२)

- **दुष्टिहेतु :**

अकालयोनिगमनाग्निग्रहादतिमैथुनात्।

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा। (च.वि ५/१८)

- **दुष्टीलक्षणे :**

शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यमहर्षणम्। रोगि वा क्लीबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते॥

न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि। शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते नरम्॥

(च.सू. २८/१८, १९)

- **विद्धलक्षणे :** तत्र विद्धस्य क्लीबता चिरात् प्रसेको रक्तशुक्रता च।

(सु.शा. ९/१३)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

मांसवह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

मांसवहानां च स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक् च। (च.वि.५/४)

मांसवहे द्वे, तयोर्मूलं स्नायुत्वचं रक्तवहाश्च धमन्यः। (सु.शा.९/१२)

- **दुष्टीहेतु :**

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च।

मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा॥ (च.वि. ५/१४)

- **दुष्टीलक्षणे :**

अधिमांसार्बुदं कीलं गलशालूकशुण्डिके।

पूतिमांसालजीगण्डगण्डमालोपजिह्विकाः॥ (च.सू.२८/१३-१४)

- **विद्धलक्षणे :**

तत्र विद्धस्य श्वयथुर्मांसशोषः सिराग्रन्थयो मरणं च। (सु.शा. ९/१२)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

मेदोवह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च।
मेदोवहे द्वे. तयोर्मूलं कटी वृक्कौ च।

(च.वि. ५/४)

(सु.शा. ९/१२)

- **दुष्टीहेतु :**

अव्यायामाद्विवास्वप्नान्मेद्यानां चातिभक्षणात्।
मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारूण्याश्चातिसेवनात्॥

(च.वि. ५/१५)

- **दृष्टि लक्षणे :**

मेदः संश्रसांस्तु प्रचक्ष्महे। निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च।

(च.सु. २८/१५)

- **विद्धलक्षणे:**

तत्र विद्धस्य स्वेदागमनं स्निग्धाङ्गता तालुशोषः
स्थूलशोफता पिपासा च।

(सु.शा. ९/१२)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

मज्जावह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

मज्जावहानां स्रोतसामस्थीनि मूलं सन्धयश्च। (च.वि. ५/४)

- **दुष्टीहेतु :**

उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात् प्रपीडनात्।

मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरूढानां च सेवनात्॥ (च.वि. ५/१७)

- **दुष्टीलक्षणे :**

रूक् पर्वणां भ्रमो मूर्च्छा दर्शनं तमसस्तथा।

अरूषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम्॥ (च.सू. २८/१७)

अन्नवह स्रोतस्

मूलस्थान

अन्नवहानां स्रोतसां आमाशयो मूलं वामंच पार्श्वम् । च.वि. ५/८
अन्नवहे द्वे, तयोर्मूलमामाशयोऽन्नवाहिन्यश्च धमन्यः । सु.शा ९/१३

दुष्टिहेतू

अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च अभोजनात् ।
अन्नवाहिनि दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च ॥ च. वि ५/२०

दुष्टिलक्षणे

अनन्नाभिलषणमरोचकाविपाको, छर्दि च दृष्ट्वा-
ऽन्नवहानि स्रोतांसि प्रदुष्टान् इति विद्यात् ॥ च. वि. ५/११

विध्द लक्षण

तत्र विध्दस्याध्मानं शूलोऽन्नद्वेषश्छर्दि :-
पिपासाऽऽन्ध्यं मरणं च ॥ सु. शा. ९/१३

रसवह स्रोतस

मूलस्थान

रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः । च.वि. ५/८
रसवहे द्वे तयोः मूलं हृदयं रसवाहिन्यः च धमन्यः । सु.शा .९/१२

दुष्टीहेतू

अश्रद्धा च अरुचिः आस्यवैरस्यं अरसज्ञता ।
हृल्लासो गौरवं तन्द्रा साङ्गमर्दो ज्वरः तमः ॥
पाण्डुत्वं स्रोतसां रोधः क्लैब्यं सादः कृशाङ्गता ।
नाशो अग्ने अयथाकालं वलयः पलितानि च ॥ च. सू २८/९-१०

दुष्टीलक्षणे

गुरुशीतमतिरिण्मधमतिमात्रं समश्नताम् ।
रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् । च.वि. ५/१३

विध्द लक्षणे

विद्धस्य शोषः प्राणवहविद्धवत् च मरणं तत् लिङ्गानि च । सु.शा .९/१२

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

रक्तवह स्रोतस

- **मूलस्थान :**

शोणितवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च। (च.वि. ५/४)
रक्तवहे द्वे, तयोर्मूलं यकृत्प्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्यः। (सु.शा.९/१२)

- **दुष्टीहेतुः**

विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च।
रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ। (च.वि. ५/१३)

- **दुष्टीलक्षणे :**

कुष्ठवीसर्पपिडका रक्तपित्तमसृग्दरः। गुदमेद्रास्यपाकश्च प्लीहा
गुल्मोऽथ विद्रधिः॥ नीलिका कामला व्यङ्गः पिप्पलवस्तिलकालकाः॥
दद्गुश्चर्मदलं शिवत्रं पामा कोठाअस्रमण्डलम्॥ रक्तप्रदोषाज्जायन्ते (च.सू.२८/११,१२)

- **विद्वलक्षणे :**

तत्र विद्वस्य श्यावाङ्गता ज्वरो दाहः पाण्डुता शोणितागमनं रक्तनेत्रता च। (सु.शा.९/१२)

Department of Rog-Nidan Evum Vikritivigyan

Ashta Mahagad

Charaka	Sushruta	Vagbhata
Vatvyadhi	Vatvyadhi	Vatvyadhi
Madhumeha	Prameha	Prameha
Kushtha	Kushtha	Kushtha
Shotha	Arsha	Arsha
Rajayakshma	Bhagandar	Bhagandar
Apasmar	Ashmari	Ashmari
Gulma	Moodhagarbha	Grahani
Udar	Udar	Udar

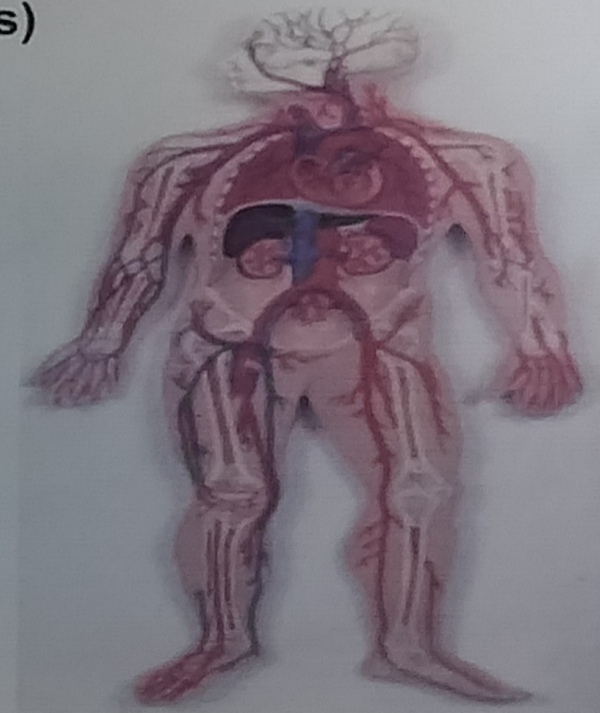
Department of Rog-Nidan Evum Vikritivigyan
Purisha Pariksha

No.	Character Of Stool	Significance			
			10	Indigested food in ama stool	Weak Digestive Power
	Black, smoky , foamy , dry, scybalous stools	Vata Dosha	11	Foul smelling and cold	Indigestion
	Yellow, watery, Foul smelling	Pitta Dosha	12	White, foul smelling, heavy	Ascites
	White, sticky mucoid stool	Kapha Dosha	13	Dark coloured stools	Wasting diseases
	Reddish brown	Vata and Kapha	14	Yellow with pain in waist	Rheumatic
	Shiny and Foul smelling	Vata + Pitta and Kapha	15	Too white , too black, dark yellow or reddish and very hot stools	Patient is going to die
6	Yellowish dark not well mixed	Pitta + Vata Dosha	16	Very foul smelling , multicoloured mimicking meat pieces	Patient is going to die
7	Yellowish dark, sticky, semisolid	Pitta + Kapha Dosha			
8	Dry stool	Lees Feeds ,Vata Dosha	17	Stool which sinks in water	Digestive power is poor or Ama Dosha
9	Loose stools	Weak digestive power, Malabsorption .	18	Stool which floats in water	Good Digestive power

Department of Rog-Nidan Evum Vikritivigyan

Concept of Srotas In Body (Macro & Micro Channels of Circulation)

- * Human body is made up of srotas (Macro & Micro Channels)
- * Smooth Flow of materials inside channels leads to health & fitness
- * Obstruction in srotas initiates the disease process- intracellular to system level
- * E.g.- The Function of athero-thrombotic plaques is responsible for Cardiovascular disorders
- * Endothelial dysfunction leads to obstruction and variety of diseases in the body
- * Srotas concept is very significant from clinical point of view for prevention & cure of diseases



★ संतर्पण-अपतर्पणोत्थ विकार ★

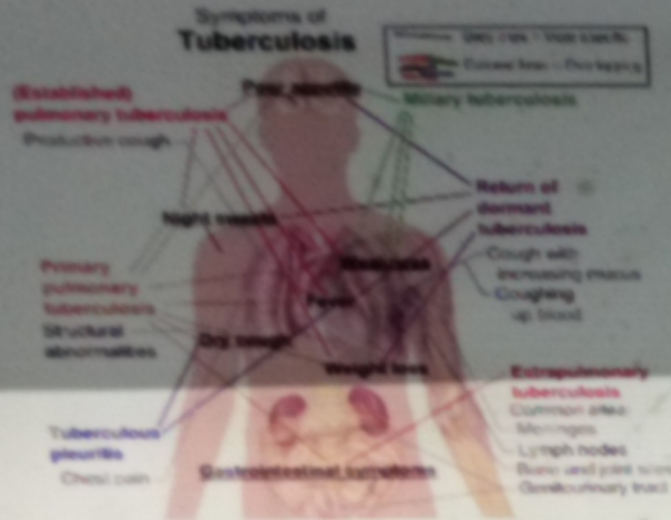
सन्तर्पणजन्य विकार हेतु सन्तर्पयति यः रिन्गधैर्मधुरैर्गुरुपिच्छिलैः।
नवान्नैर्नवमद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः॥
गोरसैर्गौंडिकैश्चान्नैः पैष्टिकैश्चातिमात्रशः।
चेष्टाद्वेषी दिवास्वप्रशय्यासनसुखे रतः॥
रोगास्तस्योपजायन्ते सन्तर्पणनिमित्तजाः। (च.सू. 23/3,4)

संतर्पणोत्थ विकार प्रमेहपिडकाकोठकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः॥
कुष्ठान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकृच्छमरोचकः।
तन्द्रा क्लैब्यमतिस्थौल्यमालस्यं गुरुगायता ॥
इन्द्रियस्त्रोतसां लेपो बुध्देर्मोहः प्रमीलकः।
शोफाश्चैवंविधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिकुर्वतः॥ (च.सू. 23/5-7)

अपतर्पणोत्थ विकार देहाग्निबलवर्णोजः शुक्रमांसपरिक्षयः।
ज्वरः कासानुबन्धश्च पार्श्वशूलमरोचकः॥
श्रोत्रदौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा।
विणूत्रसंग्रहः शूलं जडोरुत्रिकसंश्रयम् ॥
पर्वास्थिसन्धिभेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः।
ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात् ॥ (च.सू. 23/27-29)

TUBERCULOSIS

Tuberculosis (TB) is caused by a bacterium called mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lungs, but TB bacteria can attack any part of the body such as kidney, spine and brain. Not everyone infected with TB bacteria becomes sick. As a result, to TB – related condition exist : latent TB infection (LTBI) and TB disease. If not treated properly , TB disease can be fatal.



SEVERE SYMPTOMS

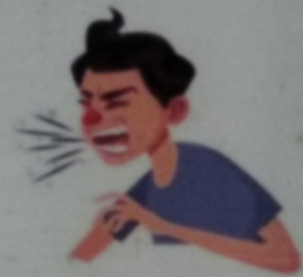
- Persistent cough
- Chest pain
- Coughing with bloody sputum
- Shortness of breath
- Urine discoloration
- Cloudy & reddish urine
- Fever with chills
- Fatigue

How is TB spread ?

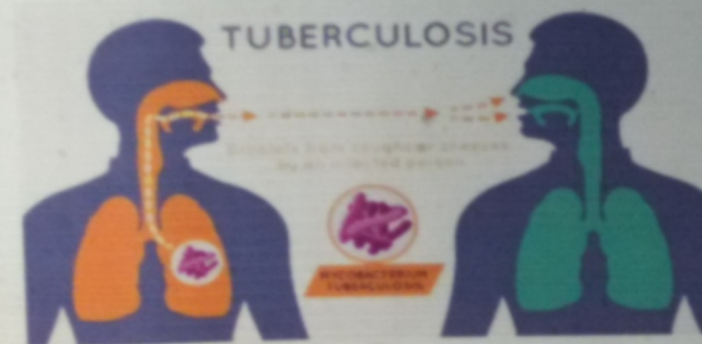
Spitting everywhere



Crowded places with poor ventilation



Coughing without covering the mouth



TB skin test (TST)	TB blood test's
If a person is found to be infected with TB bacteria, other test are needed to see if a person has latent TB Infection or TB disease.	TB bacteria are put into the air when a person with active TB disease of the lungs and throat cough's, sneezes, speaks

Guide :- Dr. Sunita Gupta (Ass. Professor)

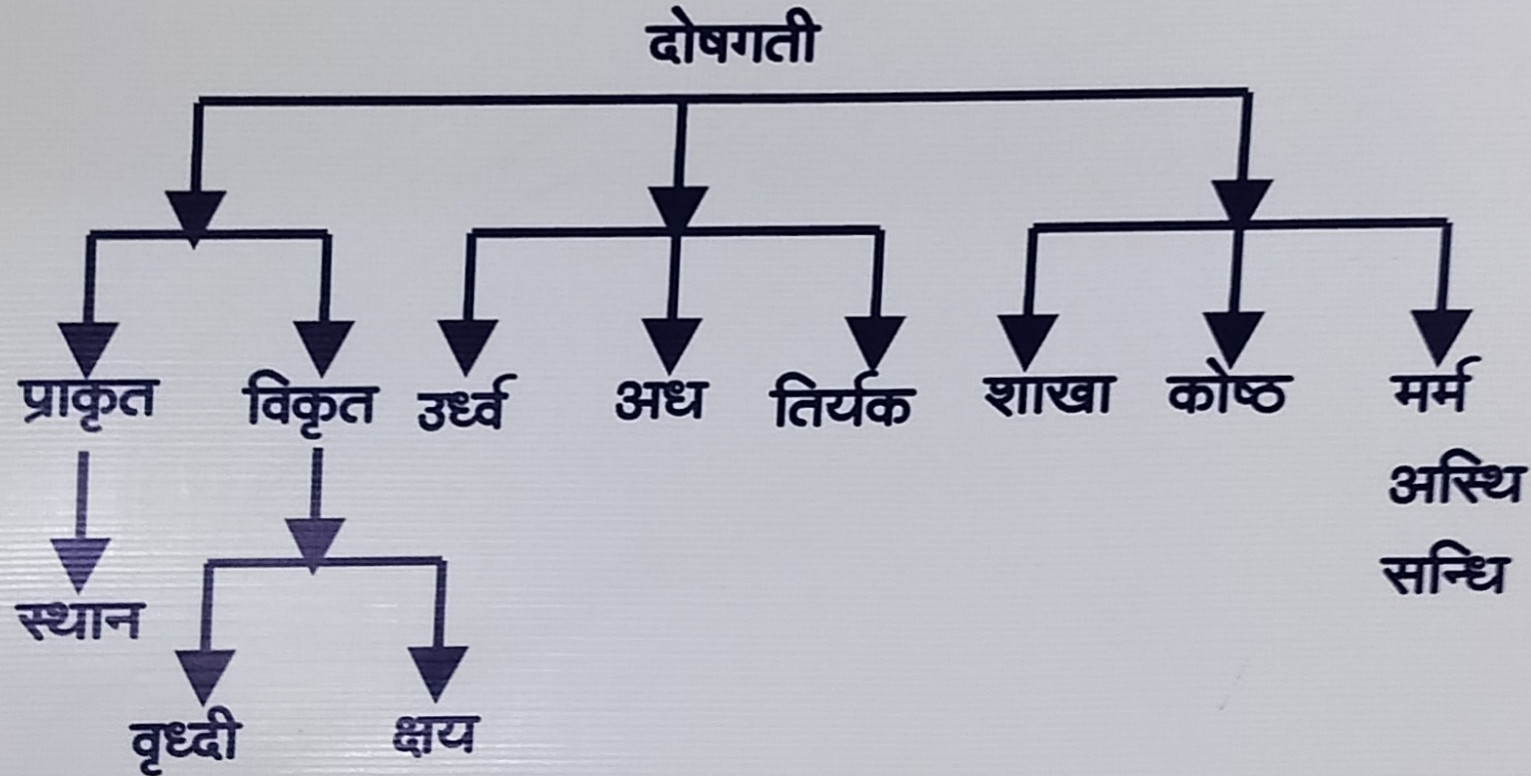
Presentation by :- 2nd year BAMS (Batch 2019-20)

रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

दोषगती

क्षय : स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ।
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥
त्रिविधा च अपरा कोष्ठाशाखा मर्मस्थिसन्धिषु ।
इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः ॥

- च.सू. १७/११२-११३



रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान

व्याधीचे प्रकार

- उपधातुप्रदोषन व्याधी

स्नायौ सिराकंडराभ्यो दुष्टाः क्लिश्नन्ति मानवम्।

स्तंभसंकोचखल्लीभिः ग्रंथिस्फुरणसुप्तिभिः॥ (च.सु.२८/२१)

- मलप्रदोषज व्याधी

मलानाश्रित्य कुपिता भेदशोप्रदुषणम्।

दोषा मलानां कुर्वन्ति संगोत्सर्गावतीव च। (च.सु.२८/२२)

- इंद्रिय प्रदोषज व्याधी

इंद्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः।

उपघातोपताभ्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ (च.सु.२८/२०)

Chicken pox-Varicella

A highly contagious disease marked by an itchy, blister-like rash caused by the varicella-zoster virus (a type of herpes virus).

- **Agent:** Varicella-zoster virus
- **Characterised by:** Vesicular rash
- **Period of communicability:** -1-2 day (before app of rash)
-4-5 days after app of rash
- **Transmission** --by droplet infection
-personal contact
- **Incubation** - 14-16 days period



Clinical features (Signs & symptoms):

<u>1) Pre-eruptive stage</u>	<u>2) Eruptive stage</u>
• sudden onset with mild or moderate fever • pain in back, shivering, malaise	• Rash is first sign (on the day fever starts) • Rash first on trunk then on face, arms, legs • Rash is pleomorphic & goes through stages macule-papule-vesicle-scab • Scabbing : 4-7 day after rash appers

varicella virus vaccine

12-18 months who haven't had chicken pox)

Varicella is detected by VZV DNA using PCR.

Acid-fast (AFB) Staining (by Ziehl-Neelsen Method)

Acid-fast staining is a microbiology technique used to identify acid-fast bacteria, primarily Mycobacterium, which has waxy cell wall resistant to decolorization by acids.

Procedure:

Smear Preparation :

- Take a slide and apply a thin film of sample (e.g. sputum) on the slide.
- Air dry it.
- Heat fix the sample on the slide
- Keep the slide on the staining rack.

Primary stain:

- Take sufficient amount of carbolfuchsin in a test tube and heat till steam comes out of the test tube. (Do not boil)
- Pour this heated carbolfuchsin on the slide and allow it to act for 5 minutes.
- Wash the slide well with distilled water.

Decolorization:

- Decolourise with 20% H_2SO_4 for tubercle bacilli and with 5% H_2SO_4 for lepra bacilli, by allowing the acid to act for 5 mins.
- Repeat with 20% H_2SO_4 for 2-3 times.
- Wash slide with distilled water.

Counterstain:

- Counter stain with 1% methylene blue or 1% malachite green for 1 min.
- Wash with distilled water.
- Dry with blotting paper and observe under 100X magnification of microscope.

OBSERVATION: The stained smear is observed under the microscope.

- a. Acid-fast bacteria will appear red or pink
- b. Non-acid fast bacteria will appear blue or green.



GRAM STAINING

Defination - gram staining is bacteriological technique which classifies the bacterias into 2 categories i.e Gram positive and Gram negative

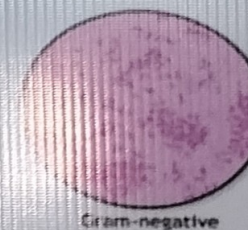
Stains used CRYSTAL VIOLET (PRIMARY STAIN),GRAM IODINE,ETHANOL OR

Procedure - GRAM STAIN PROTOCOL ACETONE,SAFRANIN

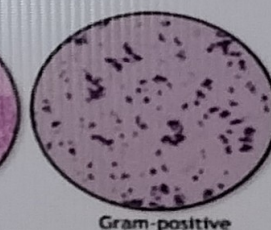
Prepare smear on a clean glass slide
 ↓
 Air dry & heat fix
 ↓
 Stain with crystal violet for 1 min
 ↓
 Wash with water
 ↓
 Pour gram's iodine for 30 sec
 ↓
 Wash with water
 ↓
 Decolourize with 95% ethanol in acetone for 30 sec
 ↓
 Wash with water
 ↓
 Stain with safranin for 1 min
 ↓
 Wash with water
 ↓
 Blot it dry and observe under the microscope.

	Gram Positive Cell wall	Gram Negative Cell wall
DEFINITION	Cell wall of gram positive bacteria, which has a thick peptidoglycan layer	Cell wall of gram negative bacteria, which has a thin peptidoglycan layer
PEPTIDOGLYCAN LAYER	Thick peptidoglycan layer	Thin peptidoglycan layer
OUTCOME OF GRAM STAINING	Stains in purple colour	Stains in pink colour
TEICHOIC ACIDS	Present	Absent
OUTER MEMBRANE	Does not contain an outer membrane	Contains an outer membrane
RETENTION OF CRYSTAL VIOLET	Retains crystal violet	Does not retain crystal violet
RESISTANCE AGAINST ANTIBIOTICS	Less resistant to antibiotics	More resistant to antibiotics
LAYERS OF PEPTIDOGLYCAN	Multilayered peptidoglycan layer	Single peptidoglycan layer
PERMEABILITY	Absent	Present
CELL SHAPE	Spherical	Rod shaped
CELL SIZE	High	High

Gram Positive	Gram Negative
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Salmonella</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Escherichia coli</i>



Gram-negative



Gram-positive

DENGUE

- Definition** :- Viral infection caused by the dengue virus (DENV) which is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes mainly *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*.
- Agent** :- *Aedes Mosquito*
- Period of Communicability** :- Up to 2 days (Before illness onset) and 5 days (after onset)
- Transmission** :- Through the bite of infected female *Aedes* mosquitoes
- Incubation Period** :- Typically lasts - 4 to 7 days ,with range of 3 to 14 days



Restlessness

Sign and symptoms according to type of dengue :-

Type of Dengue	Symptoms
1] Classic Dengue Fever	High fever, Severe headache, Pain behind eyes, Muscle and joint pain, Nausea , Vomiting, Skin rash , Fatigue
2] Dengue Shock Syndrome	Symptoms of dengue Haemorrhagic fever, Low BP , Skin -clammy , Rapid pulse
3] Dengue Haemorrhagic Fever	Symptoms of classic dengue , Bleeding (nose, gums etc), Low platelet count , Swelling, Blood in Vomit and stool

Vaccine :- Dengvaxia (CYD -TDV)
Qdenga (TAK-003)

Investigation :-

- 1] Dengue NS1 Antigen Test
- 2] Molecular Test (RT-PCR)
- 3] Serological Test (Antibody Detection)
- 4] IgM/IgG Ratio Test



Drop in body temperature



Bleeding from gums

Topic : Edema

Defination : Edema is defined as abnormal and excessive accumulation of 'free fluid' in the interstitial tissue spaces and serous cavities.

	Pitting Edema	Non-pitting Edema
DEFINITION	Pitting edema occurs when excess fluid builds up in the body, causing swelling that indents when pressure is applied	Non-pitting edema occurs when excess fluid builds up in the body and causes swelling that does not indent when pressure is applied
CAUSE	Problems in the liver, kidney, lymphatic system, lung diseases, obesity, pregnancy, medications, low levels of protein, and heart failure	Lymphedema, myxedema, angioedema, and lipedema
SIGNS AND SYMPTOMS	Indentations on the skin when pressure is applied, full or heavy feeling, joints that may be hard to move, stretched, shiny or reddened skin, warm or hot skin, dough-like skin, tenderness, trouble walking, fatigue, trouble breathing, shortness of breath, coughing and chest pain	Indentation on the skin when pressure is applied, tenderness, tense skin, limited movement, and heaviness that can interfere with walking and lead to ulcers and infections on the skin in severe cases
DIAGNOSIS	Physical examination, blood tests, kidney and liver function tests, and electrocardiogram (ECG or EKG)	Medical history, physical examination, thyroid function tests, or a specific type of radioactive imaging called lymphoscintigraphy
TREATMENTS	Elevating the swollen limbs above the level of the heart, undergoing vascular surgery, wearing compression stockings for better circulation, increasing blood protein levels, and taking diuretics to flush out excess fluid	Using gentle massage to stimulate fluid movement and open up lymphatic capillaries, following a skincare routine to maintain moisture, wrapping the area with bandages, exercising, wearing compression garments, liposuction, and taking synthetic T4 hormone called levothyroxine to balance thyroid hormones



रोगनिदान एवं विकृतीविज्ञान

★ स्वेदवह स्रोतस ★

मुलस्थान -

स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं लोमकूपाश्च । (च.वि. 5/8)

दुष्टिकारणे -

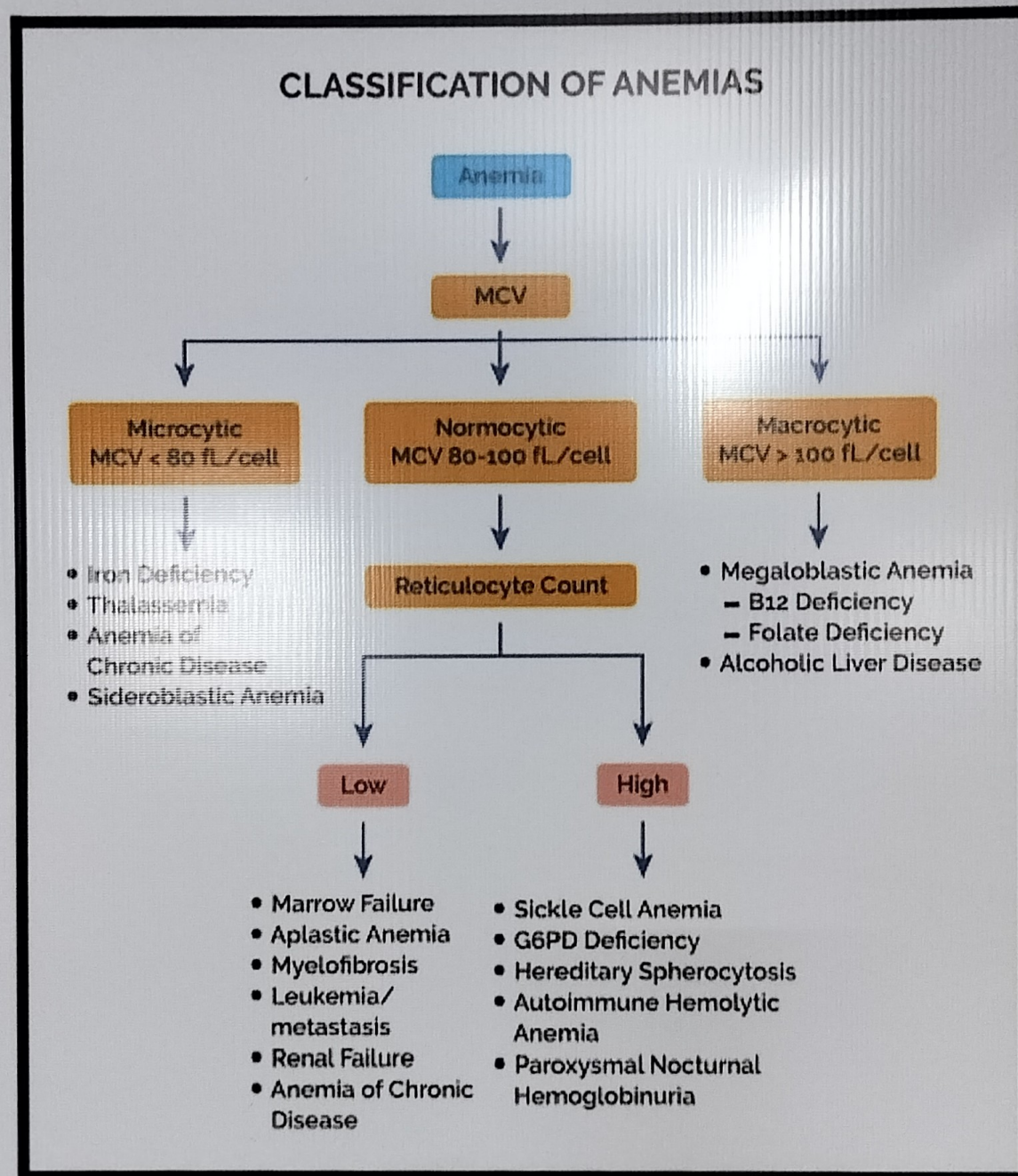
व्यायामात् अति संतापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् ।
स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयेस्तथा ॥ (च.वि. 5/22)

दुष्टिलक्षणे -

अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम्
अतिश्लक्ष्णतामङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च
दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥
(च.वि. 5/8)

Reference : चरक संहिता

Definition - Anemia represents a decrease in red cell mass of hemoglobin contents of blood below physiological needs as set by tissue oxygen demand.



उदकवह स्रोतस्

मूलस्थान

उदकवहानां स्रोतसां तालु मूलं क्लोमं च ॥ च.वि. ५/७
उदकवहे द्वे, तयोर्मूलं तालु क्लोम च ॥ सु.शा. ९/१२

दुष्टीहेतू

औष्ण्यात् आमात् भयात् पानात् अतिशुष्कान्नसेवनात् ।
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाः च अति पीडनात् ॥ च.वि. ५/११

दुष्टीलक्षणे

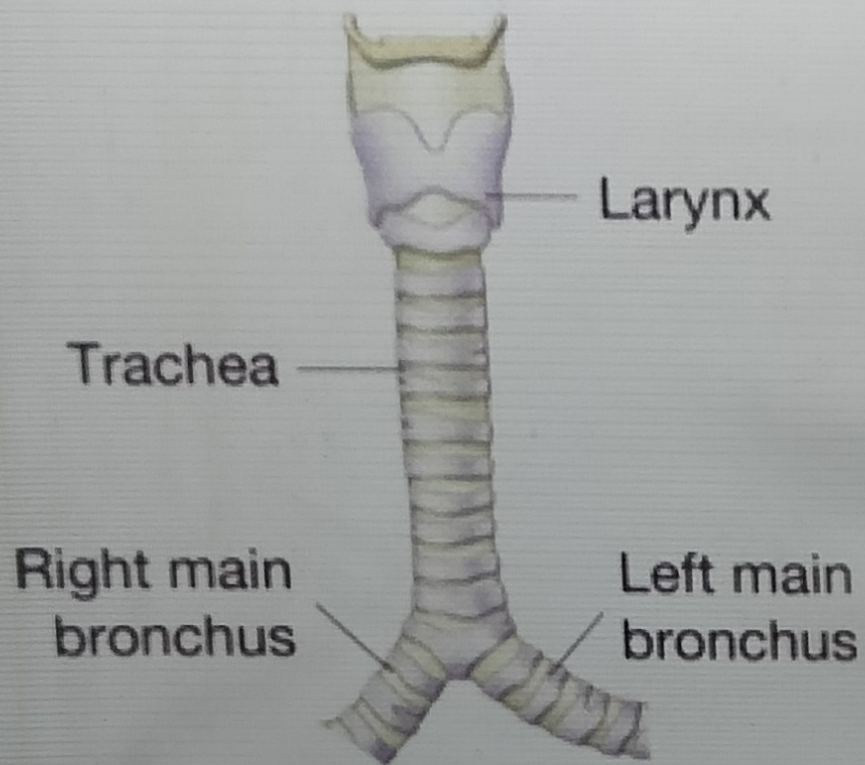
जिह्वा तालु ओष्ठ कण्ठ क्लोम शोषं पिपासां च
अति प्रवृद्धं दृष्ट्वा उदकवहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टान् इति विद्यात् ॥ च.वि. ५/७

विध्द लक्षणे

तत्र विध्दस्य पिपासा सद्यो मरणं च ॥ सु.शा. ९/१२

Srotas

Sthul Srotas



Sukshma Srotas

